

סוכרת היריונית

הוכן על-ידי:

פרופ' טל בירון-שנטל
ד"ר חן סלע
פרופ' רינת גבאי בן זיו
פרופ' לירן הירש
ד"ר דנה ויטנר
פרופ' גלי פריאנטה
ד"ר הדר רוזן

בשם:

החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
האיגוד הישראלי למיילדות וגinekולוגיה

נייר עמדה מספר 16
יולי 2023



ניירות עמדה מתפרסמים ככלי עזר לרופא/ה ואינם באים במקום שיקול דעתו/ה בכל מצב נתון

עדכון אושר במועצת האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה , מאי 2023

הקדמה

סוכרת היריונית מוגדרת כמצב של אי-סבילות לגלוקוז המופיע או מאובחן לראשונה במהלך ההיריון. שכיחותה של סוכרת היריונית הינה כ-15%-4% כתלות בשכיחות סוכרת מסוג 2 באוכלוסייה הנתונה. סוכרת היריונית מעלה את שיעור הסיבוכים האימהיים והעובריים כגון מחלות יתר לחץ דם, טראומה בלידה, לידות מכשירניות, ניתוחים קיסריים, מקרוזומיה, פרע כתפיים והיפוגליקמיה ניאונטלית. השלכות ארוכות טווח אפשריות לנשים ההרות הן התפתחות סוכרת מסוג 2 בעתיד, ולילודים - השמנת יתר וסוכרת בצעירותם.

אשר על כן עמדת האיגוד היא:

אבחנה

בהתייחס לבדיקת גלוקוז בצום (לפחות 8 שעות) בבדיקות דם בטרימסטר הראשון:

■ גלוקוז בצום 126 מ"ג/ד"ל ומעלה - יש להתייחס כסוכרת טרום היריונית.

■ גלוקוז בצום בין 95-125 מ"ג/ד"ל - אין אחידות המלצות בספרות לגבי ההשלכות ולאופן ההתייחסות והנושא נותר שנוי במחלוקת. בנשים אלו מומלץ לבצע בשבוע 24-28 העמסת סוכר של 100 גרם (OGTT – oral glucose challenge test) ולא 50 גרם (GCT – Glucose challenge test).

■ גלוקוז בצום מתחת ל 95 מ"ג/ד"ל - בדיקה תקינה. באם מתקבל ערך של 95 ומעלה מומלץ לאמת את התוצאה בבדיקה נוספת.

אבחנת סוכרת היריונית תתבצע בשני שלבים:

יש לבצע בדיקת סקר של העמסת סוכר 50 גרם (GCT) לכלל אוכלוסיית הנשים ההרות בשבועות 24-28 להיריון, ללא צורך בהנחיות צום או בדיאטה מיוחדת קודם לבדיקה. שעה לאחר שתיית 50 גרם גלוקוז תימדד רמת הגלוקוז בפלזמה. ערך של 140 מ"ג/ד"ל ומעלה ייחשב כלא תקין. במקרה זה יומלץ לבצע בהקדם האפשרי את הבדיקה האבחנתית - העמסת סוכר של 100 גרם (OGTT). בבדיקה זו, לאחר צום של 8-14 שעות יימדדו ערכי הגלוקוז בפלזמה בצום ושעה, שעתיים ושלוש שעות - לאחר ההעמסה. ערכי הגלוקוז יוגדרו כפתולוגיים כאשר הם שווים או גבוהים מ 95, 180, 155 ו-140 מ"ג/ד"ל בהתאמה. אבחנת סוכרת היריונית תיעשה במידה

ושני ערכים יימצאו פתולוגיים בבדיקה. במקרים של ערך אחד פתולוגי וגורמי סיכון נוספים (כגון: השמנת יתר, גיל מבוגר, סוכרת בהיריון קודם או לידה בעבר מעל 4000 גרם) יש לשקול ביצוע עקומת סוכר והפנייה למרפאה להיריון בסיכון גבוה.

בנשים בעלות מדד מסת גוף (BMI) טרום-היריוני גבוה מ-30 ק"ג/מ"ר, בנשים עם סוכרת היריונית בהיריונות קודמים ובנשים עם לידה בעבר של ילוד מעל 4500 גרם - יש להמליץ על ביצוע הבדיקה האבחנתית (OGTT) ללא בדיקת הסקר.

תוצאה של מעל 200 מ"ג/ד"ל ב-GCT מגדירה סוכרת היריונית ואין צורך לבצע בדיקות נוספות לאישור האבחנה. לצורך בדיקות הסקר והאבחנה (GCT, OGTT) אין להשתמש במכשירי ניטור גלוקוז ביתיים (גלוקומטר), אלא בבדיקת רמות גלוקוז בפלזמה.

יודגש כי אבחון סוכרת היריונית באמצעות OGTT בספרות הרפואית מתבסס על ביצוע הבדיקה בשבועות 24-28 להיריון, ולכן בדיקה שבוצעה מחוץ לטווחים אלו אינה מהימנה באותה המידה.

טיפול

הטיפול בסוכרת היריון הוכח בספרות כקשור בהפחתת הסיבוכים הפרינטייליים לעומת היעדר טיפול. הטיפול בסוכרת היריונית מבוסס על דיאטה, פעילות גופנית וטיפול תרופתי.

ערכי הגלוקוז המקסימליים המומלצים לאיזון האישה ההרה הסוכרתית במהלך ההיריון (במ"ג/ד"ל):

- צום בוקר: נמוך מ-95
- טרום ארוחות: נמוך מ-95
- שעה לאחר תחילת הארוחה: 140
- שעתיים לאחר תחילת הארוחה: 120
- ממוצע יומי: נמוך מ-100

המלצות לטיפול התזונתי ולפעילות גופנית תינתנה בסמוך לאבחנת הסוכרת ההיריונית.

דיאטה מומלצת

מומלצת התאמת תזונה אישית לכל אישה הרה.

עקרונות הפעילות הגופנית

פעילות גופנית מומלצת לכל הנשים עם סוכרת לצורך שיפור האיזון הגליקמי. יש להתאים את ההמלצה לפעילות גופנית לכל אישה הרה בנפרד בהתאם ליכולתה ולמגבלות ההיריון.

טיפול תרופתי

טיפול תרופתי יינתן לכל אישה הרה שאובחנה עם סוכרת היריונית אצלה רמות הגלוקוז הרצויות (כמפורט לעיל) אינן מושגות ע"י פעילות גופנית ודיאטה תוך 2-4 שבועות.

סוגי התרופות השכיחות בשימוש לאיזון סוכרת היריונית:

- אינסולין – מקובל להשתמש באינסולין קצר טווח, בינוני או ארוך טווח בהתאם לעקומת הסוכר. אינסולין במינונים המקובלים אינו חוצה שליה ובטיחותי לעובר.
- מטפורמין (METFORMIN) - ניתן להשתמש במטפורמין לאיזון סוכרת היריונית. מטפורמין חוצה את השליה, אך לא נמצא כטרטוגני. ניתן לטיפול בכל שלבי ההיריון. מינון מקובל עד 850 מ"ג 3 פעמים ביממה.
- גלובן (GLIBENCLAMIDE) - ניתן לטפל בגלובן לאיזון סוכרת היריונית. תרופה זו אינה חוצה את השליה בכמות משמעותית. ניתן לטפל בגלובן מסוף השליש הראשון. אין לתת תרופה זו בנשים הרגישות לסולפה. המינון המקובל הוא עד 20 מ"ג ליממה.

מעקב ההיריון בסוכרת היריונית

מומלץ לבצע בדיקות עצמיות בתדירות שתיקבע על סמך רמות הסוכר, בעזרת מכשיר ביתי הבדוק את רמות הסוכר בדם הנימי (גלוקומטר) או במד סוכר רציף (CGM). בשימוש בגלוקומטר, מומלץ לבדוק את רמות הסוכר בין ארבע לשבע פעמים ביום. ערכי הבדיקה העצמית בצום ושעה או שעתיים לאחר תחילת כל הארוחות הגדולות הם בעלי החשיבות הגדולה ביותר לסיבוכי ההיריון.

תדירות המעקב הרפואי תיקבע לפי חומרת הסוכרת ומידת האיזון. התדירות המקובלת לביקורי רופא נעה בין פעם בשבוע לפעם בארבעה שבועות.

תדירות מומלצת לביצוע ניטור עוברי במהלך ההיריון עם סוכרת היריונית לא נקבעה באופן חד - משמעי. ניתן לשקול להתחיל ולנטר את העובר החל משבוע 32-34 לפי גורמי הסיכון הקיימים, כגון הצורך בטיפול תרופתי, איזון לא מספק של רמות הגלוקוז, היסטוריה מיילדותית ומחלת יל"ד. אין מחקרים אשר הוכיחו קשר בין סוכרת היריונית לבין מות עובר תוך - רחמי.

הניטור יכלול פרופיל ביופיזיקלי (BPP – Biophysical profile) ו/או מוניטור עוברי (NST – Non stress test) לפי שיקול דעתו של הרופא המטפל.

הלידה

אין יתרון ליילוד יזום של הרה עם סוכרת היריונית המאוזנת היטב (ללא קשר לאופן הטיפול) עם הערכת משקל התואמת את גיל ההיריון לפני שבוע 40. מומלץ לשקול יילוד יזום בהתאם לנוכחות גורמי סיכון אימהיים ועובריים ולפי שיקול דעת הצוות המטפל. במידה וקיימת הערכת משקל קלינית וסונוגרפית של מעל 4250 גרם, מומלץ לבצע ניתוח קיסרי אלקטיבי ללא ניסיון לידה.

לאחר הלידה

יש להמליץ על ביצוע בדיקת OGTT של 75 גרם בשבועות 4-12 לאחר הלידה, על מנת לזהות נשים שלהן אי סבילות לגלוקוז או סוכרת.

ביבליוגרפיה

1. American Diabetes Association; 2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes—2021. *Diabetes Care* 1 January 2021; 44 (Supplement_1): S15–S33.
2. Powers AC: Diabetes mellitus. In Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, et al (eds): *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 15th ed. New York, McGraw-Hill, 2001, p 2109.
3. Sheffield JS, Casey BM, Lucas MJ, et al: Gestational diabetes: Effects of the degree of hyperglycemia and the gestational age at diagnosis. *Soc Gynecol Invest* 6:6A, 1999
4. Retnakaran R, Zinman B, Connelly PW, Sermer M, Hanley AJ. Impaired Glucose tolerance of pregnancy is a heterogeneous metabolic disorder as defined by the glycemic response to the oral Glucose tolerance test. *Diabetes Care*. 2006;29(1):57-62
5. Crowther CA, Hiller JE, Moss JR, McPhee AJ, Jeffries WS, Robinson JS; Australian Carbohydrate Intolerance Study in Pregnant Women (ACHOIS) Trial Group. *N Engl J Med*. 2005 16; 352(24):2477-2486. (Level-I)
6. Langer O, Yogev Y, Most O, Xenakis EM. Gestational diabetes: the consequences of not treating. *Am J Obstet Gynecol*. 2005; 192(4):989-997. (Level –II-2)
7. McFarland MB, Langer O, Conway DL, Berkus MD. Dietary therapy for gestational diabetes: how long is long enough? *Obstet Gynecol* 1999; 93:978–982 (Level II-3)
8. Elliott BD, Schenker S, Langer O, Johnson R, Prihoda T. Comparative placental transport of oral hypoglycemic agents in humans: a model of human placental drug transfer. *Am J Obstet Gynecol*. 1994; 171(3):653-660. (Level-II)
9. Elliott BD, Langer O, Schenker S, Johnson RF. Insignificant transfer of glyburide occurs across the human placenta. *Am J Obstet Gynecol*. 1991; 165(4 Pt 1):807-812. (Level-II).
10. Hod M, Mathiesen ER, Jovanović L, McCance DR, Ivanisevic M, Durán-García S, Brøndsted L, Nazeri A, Damm P. A randomized trial comparing perinatal outcomes using insulin detemir or neutral protamine Hagedorn in type 1 diabetes. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2013 Mar 12.
11. Heller S, Damm P, Mersebach H, Skjøth TV, Kaaja R, Hod M, Durán-García S, McCance D, Mathiesen ER. Hypoglycemia in type 1 diabetic pregnancy: role of preconception insulin aspart treatment in a randomized study. *Diabetes Care*. 2010 Mar;33(3):473-7.
12. Mathiesen ER, Hod M, Ivanisevic M, Duran Garcia S, Brøndsted L, Jovanovic L, Damm P, McCance DR; Detemir in Pregnanc Study Group. Maternal efficacy and safety outcomes in a randomized, controlled trial comparing insulin detemir with NPH insulin in 310 pregnant women with type 1 diabetes. *Diabetes Care*. 2012 Oct;35(10):2012-7.

האיגוד הישראלי למיילדות וגinekולוגיה
Israel Society of Obstetrics and Gynecology



החברה הישראלית לרפואת האם והעובר
Israeli Society for Maternal-Fetal Medicine



המכון לאיכות
ברפואה



ההסתדרות הרפואית בישראל
המכון לאיכות ברפואה

